Conduite à tenir devant un ou plusieurs cas d'infection invasive à méningocoque (IIM)

Diapositives adaptées à partir de l'instruction de la DGOS du 27 juillet 2018 relative à la prophylaxie des infections invasives à méningocoque

hèse validée par le groupe recommandation de la SPILF le 14 novembre 2018

Infection à méningocoque

- *Neisseria meningitidis*

  - Bactérie strictement humaine

  - Bactérie fragile qui ne survit pas dans le milieu extérieur

  - Sérogroupes les plus répandus dans les IIM : B(62%) et C(23%)

- Transmission

  - par les sécrétions rhinopharyngées

  - risque de transmission fonction de la nature/durée de l'exposition

  - un patient est contagieux de 10 jours avant le début de l'hospitalisation jusqu'à la 1ère administration parentérale de ceftriaxone ou jusqu'à 24h après l'administration d'un

méningocoque (IIM)

Incidence annuelle 0,65 à 0,95 cas/100 000 habitants

- Définition

1. Isolement bactériologique de méningocoque ou PCR + à partir d'un site normalement stérile (sang, LCS, liquide articulaire, liquide pleural, liquide péritonéal, liquide péricardique, liquide de la chambre antérieure de l'œil) ou à partir d'une biopsie cutanée

2. Présence de diplocoques Gram - à l'examen microscopique du LCS

3. LCS évocateur de méningite bactérienne purulente (à l'exclusion de l'isolement d'une autre bactérie) ET présence d'un purpura

4. Présence d'un *purpura fulminans*

méningocoque (IIM)

- Déclaration obligatoire de tout cas d'IIM sans délai à l'ARS (signalement et notification) pour mise en œuvre des mesures prophylactiques autour du cas index
- Diagnostic microbiologique
  - Mise en culture indispensable
  - Tout matériel + doit être envoyé au CNR pour génotypage complet
  - Antibiogramme par E-test (pénicilline, céphalosporine injectable, chloramphénicol, rifampicine, ciprofloxacine)

Antibioprophylaxie autour d'un cas d'IIM

- Sujet contact

  Personne ayant été exposée directement aux sécrétions rhino-pharyngées du cas dans les 10 jours précédant le début de l'hospitalisation(personnes qui vivent/sont gardées sous le même toit que la cas index pendant sa période de contagiosité)

- Autres circonstances, évaluation du risque dépend de :

  - la proximité : distance < 1 m
  - le type de contact : face à face
  - la durée > 1 heure
  - contact « bouche à bouche » : la durée importe peu

Antibioprophylaxie autour d'un cas d'IIM

- Schéma

  - Rifampicine PO 48h (600 mgx2/j chez l'adulte, 10 mg/kg x2/j pour l'enfant)

  - en cas de contre-indication, de résistance documentée ou d'infections répétées dans une même communauté, ceftriaxone IV dose unique (250 mg chez l'adulte et 125 mg chez l'enfant) ou ciprofloxacine PO dose unique (500 mg chez l'adulte, 20 mg/kg chez l'enfant)

- A débuter dans les plus brefs délais, si possible dans les 24 à 48h après le diagnostic

- Inutile au delà de 10 jours après le dernier contact avec le cas index pendant sa période de contagiosité

Vaccination autour d'un cas d'IIM

- Vaccination uniquement proposée aux sujets contacts qui se retrouvent de façon régulière et répétée dans l'entourage proche du cas
- A réaliser dans un délai de 10 jours après le dernier contact avec le cas index dans sa période de contagiosité
- **Complète l'antibioprophylaxie** lorsque la souche responsable du cas est d'un sérogroupe A, C, W ou Y,
- Pas de vaccination pour une IIM du sérogroupe B sauf indication particulière des autorités de santé
- La survenue d'une IIM chez un sujet antérieurement vacciné contre le sérogroupe en cause doit être

IIM de sérogroupe C: schémas de vaccination

Age	Schéma
6 à 7 semaines	1 dose de Nimenrix® puis vaccin antiméningocoque selon le calendrier en vigueur
2 à 3 mois révolus	1 dose de Neisvac® ou de Menjugate®, 2ème dose à 2 mois puis rappel à 12 mois
4 mois	1 dose de Neisvac® ou 2 doses de Menjugate® à 2 mois d'intervalle, rappel à 12 mois
5 mois	• Si non vacciné contre le méningocoque C: 1 dose de Neisvac® ou 2 doses de Menjugate® à 2 mois d'intervalle, rappel au cours de la 2ème année • Si vacciné, pas de vaccination, rappel à 12 mois
6-11 mois révolus	• Si non vacciné contre le méningocoque C: 1 dose de Neisvac® ou 2 doses de Menjugate® à 2 mois d'intervalle, rappel à 12 mois • Si vacciné, pas de vaccination, rappel à 12 mois
12 mois	• Si non vacciné contre le méningocoque C: 1 dose de Neisvac® ou de Menjugate® • Si vacciné depuis moins de 6 mois: pas de vaccination • Si vacciné depuis plus de 6 mois: 1 dose de Neisvac® ou de Menjugate®

IIM de sérogroupe C: schémas de vaccination

Age	Schéma
Après 12 mois et chez l'adulte	• Si vacciné par un vaccin conjugué depuis moins de 5 ans: pas de rappel • Si vacciné par un vaccin conjugué depuis 5 ans ou plus: rappel conjugué • Si vacciné par un vaccin non conjugué contenant la valence C depuis moins de 3 ans: pas de rappel • Si vacciné par un vaccin non conjugué contenant la valence C depuis 3 ans ou plus: rappel de vaccin conjugué • Si non vacciné: 1 dose de vaccin conjugué

IIM de sérogroupe A, Y ou W: schémas de vaccination

Age	Schéma
6 semaines à 4 mois	1 dose de Nimenrix® puis vaccin antiméningocoque selon le calendrier en vigueur
5 mois	• Si non vacciné contre le méningocoque C: 1 dose de Nimenrix®, Neisvac® 1 mois plus tard et rappel Neisvac® à 12 mois • Si vacciné contre le méningocoque C: 1 dose de Nimenrix®, rappel Neisvac® à 12 mois
6 à 11 mois révolus	• Si non vacciné contre le méningocoque C: 1 dose de Nimenrix®, Neisvac® 1 mois plus tard et rappel Neisvac® au cours de la 2ème année • Si vacciné contre le méningocoque C: 1 dose de Nimenrix®, rappel Neisvac® à 12 mois
12 mois	• Si non vacciné contre le méningocoque C: 1 dose de Nimenrix® • Si vacciné contre le méningocoque C 1 dose: 1 dose de Nimenrix®

IIM de sérogroupe A, Y ou W: schémas de vaccination

Age	Schéma
Après 12 mois révolus et chez l'adulte	• Si non vacciné contre le méningocoque C: 1 dose de Nimenrix® (ou Menveo® après 2 ans) • Si vacciné par un vaccin quadrivalent conjugué depuis moins de 5 ans: pas de rappel • Si vacciné par un vaccin quadrivalent conjugué depuis 5 ans ou plus: 1 dose de Nimenrix® (ou Menveo® après 2 ans) • Si vacciné par un vaccin non conjugué depuis moins de 3 ans: pas de rappel • Si vacciné par un vaccin non conjugué depuis 3 ans ou plus: 1 dose de Nimenrix® (ou Menveo® après 2 ans) • Si vacciné par un vaccin non conjugué AC depuis moins de 3 ans: - Si contact avec IIM A: pas de vaccin - Si contact avec IIM Y ou W: 1 dose de Nimenrix® (ou Menveo® après 2 ans)

Survenue de cas liés d'IIM

- Les cas liés sont définis par la survenue de 2 cas ou plus parmi des personnes présentant un lien épidémiologique (contacts proches ou présence dans une même collectivité ou un même groupe social)

- A l'issue des investigations, seront retenues comme situations

  1. Grappe de cas: survenue de 2 cas ou plus rattachables à des souches identiques, anormalement rapprochées dans le temps, dans une même collectivité ou groupe social

  2. Epidémie: survenue dans une même communauté dans un délai ≤ 3 mois d'au moins 3 cas sans contact direct entre eux, rattachables à des souches identiques ET un taux d'attaque primaire ≥ 10 cas/100 000

  3. Hyperendémie: augmentation durable de l'incidence pour un sérogroupe donné par rapport à l'incidence habituellement